

Belo Horizonte, 03 de Abril de 2024

Relatório de Acompanhamento em Terapia Ocupacional

CECÍLIA MARIA ALBERGARIA SILVA (DN 30/06/2020 – 3a9m)

Pais : Renata Maria Albergaria Amaral, advogada e Antônio Rafael da Silva Filho, engenheiro mecânico

Idade da mãe ao nascimento : 38 anos, primeira gestação. Quadros de Diabetes e Hipotireoidismo gestacional, Síndrome de Hellp. Mãe portadora de hipotireoidismo, histórico de hipertensão e diabetes na família. Pai com histórico de diabetes, insuficiência renal e cardíaca na família. Parto normal (38s3d), Apgar 6/7, Peso ao nascer: 2,306. Não apresentou icterícia, não foi necessária internação. A criança sofre AVE hemorrágico aos 35 dias de vida, ficando internada por 58 dias. Colocada válvula de derivação ventriculoperitoneal (DVP) para tratar o acúmulo excessivo de líquido no cérebro (hidrocefalia).

Fez controle de cabeça, rolou, arrastou, sentou, engatinhou com 1 ano e 18 dias, andou com 1 ano e 8 meses, falou aos 9 meses. É desfraldada.

Apresentou estrabismo convergente, pequeno e intermitente, no primeiro semestre de vida. Atualmente mantém quadro de hipermetropia com astigmatismo, surgimento de pequena esotropia e leve preferência por OE. É acompanhada por oftalmologista (Débora Pinheiro) e terapeuta ocupacional especializada em baixa visão (Aline Brandão). Ao último teste AVIF realizado em dezembro de 2023, observou-se ganhos significativo na visão funcional e boa aceitação da correção óptica

Cecília tem sono excelente, dorme em sua própria cama. Intestino funciona regularmente (cerca de 1 a 2 vezes/dia). Necessita de alguma ajuda em atividades de higiene, vestuário e alimentação, realizando a maioria delas com supervisão. Auxilia em pequenas tarefas da rotina da casa como jogar itens no lixo, ligar máquina de lavar, pendurar blusa no cabide. Reconhece formas, cores, animais, algumas letras e números. Segue comandos simples.

Matriculada na EMEI Alaíde Lisboa, turno da manhã.

É uma criança que socializa bem, gosta de brincar sozinha e em grupo de pares ou adultos. Carinhosa, curiosa, interessada e cooperativa. Vem apresentando discurso cada vez mais elaborado, articulado e com boa argumentação.

Observado esteriotipias motoras de braços e pernas quando em euforia.

Tão logo se deu o encaminhamento de Cecília para a terapeuta ocupacional atual, em setembro de 2023, foi dada continuidade às **intervenções** programadas, a saber :

- imitação,
- traçados e cópia de formas,
- reconhecimento de objetos, figuras e associações,
- coordenação motora ampla e fina,
- ajustes posturais,
- ampliação do faz de conta.

Em 03/04/2024 foi aplicado o PEDI (PEDIATRIC AVALUATION OF DISABILITY INVENTORY). O PEDI é uma medida de funcionalidade de crianças com diferentes condições de saúde. Este teste informa aspectos consistentes com os objetivos terapêuticos funcionais e prioriza informações de desempenho funcional da criança, ou seja, o que ela consegue realizar.

Tabela de Pontuação

	Área	Escore bruto	Escore normativo	Erro padrão	Escore contínuo	Erro padrão
Habilidade funcionais	Autocuidado	67	56,3	3,7	84,23	4,00
	Mobilidade	56	53,0	5,3	65,28	2,74
	Função Social	61	67,0	4,8	87,67	4,53
Assistência do cuidador	Autocuidado	32	55,8	3,6	75,28	3,72
	Mobilidade	27	30,4	2,5	68,76	3,92
	Função Social	23	49,0	5,1	82,54	7,34

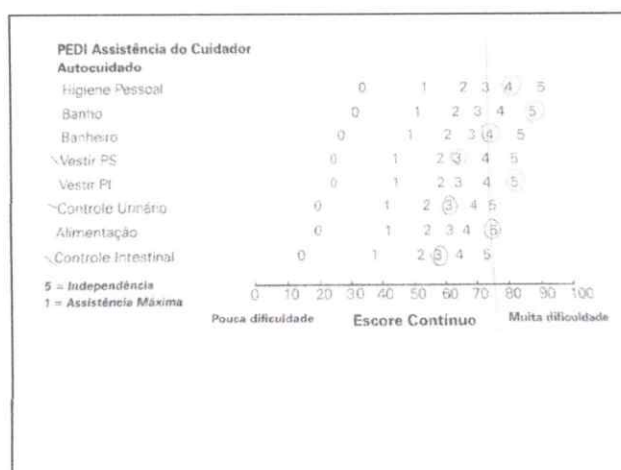
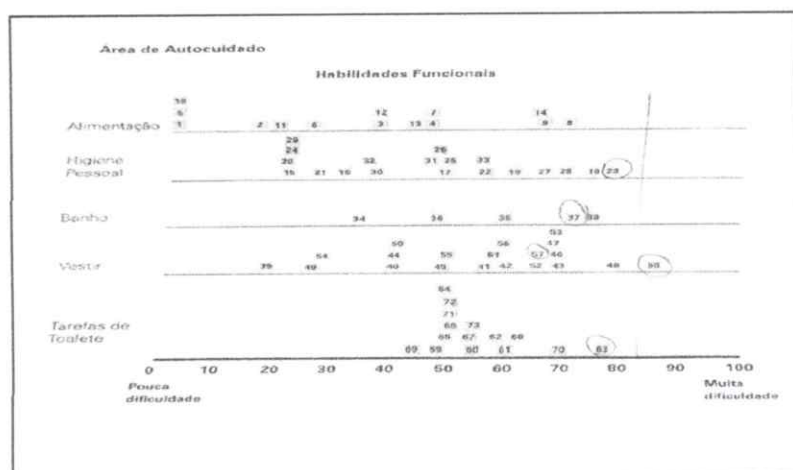
Na pontuação total, Cecília apresenta **desempenho funcional** (desempenho comparado com o esperado de crianças com desenvolvimento normal, da mesma faixa etária), sendo considerado atraso funcional pontuações abaixo de 30 no escore normativo.



MANON FARIA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

A avaliação do escore contínuo (abaixo) ilustra o perfil de desempenho da criança em um contínuo de dificuldade crescente, sem considerar faixa etária e permite comparação entre áreas de função, entre repertório de habilidades e nível de independência (assistência do cuidador).

HABILIDADE FUNCIONAL - Autocuidado



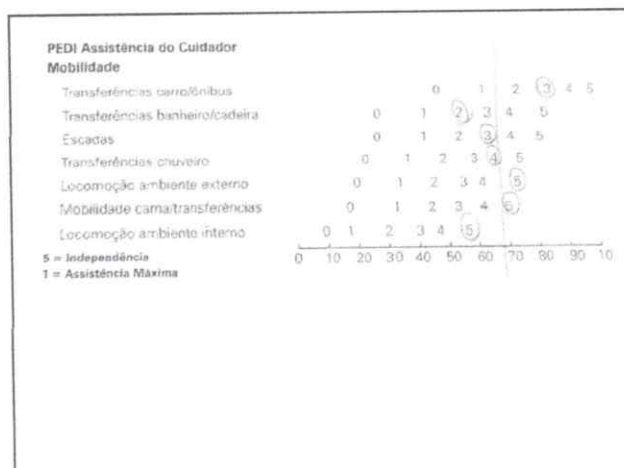
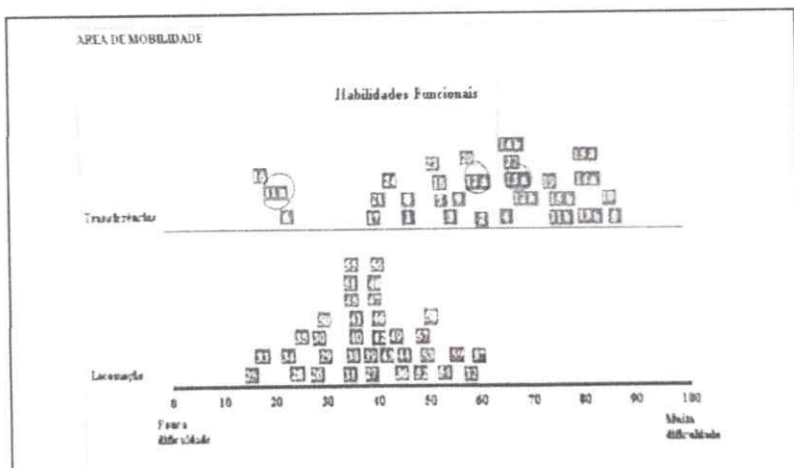
Itens para intervenção :

- 23) Desembaraçar e partir o cabelo
- 37) Secar o corpo completamente
- 57) Colocar o sapato no pé correto, maneja fechos de velcro
- 63) Limpar-se completamente depois de evacuar

Orientações ao cuidador para estímulo à autonomia da criança :

- D) Vestir - parte superior do corpo: Roupas de uso diário. Inclui ajudar a colocar e retirar splint ou prótese, não inclui tirar roupas do armário ou gavetas, lidar com fechos nas costas
- G) Controle Urinário: Controle urinário dia e noite, limpar-se após acidente e controle dos horários.
- H) Controle Intestinal: Controle do intestino dia e noite, limpar-se após acidente e controle dos horários

HABILIDADE FUNCIONAL - Mobilidade



Itens para intervenção :

11a) Movimentar-se no carro; mexer e subir/descer da cadeirinha do carro

12a) Entrar e sair do carro com pouco auxílio ou instrução

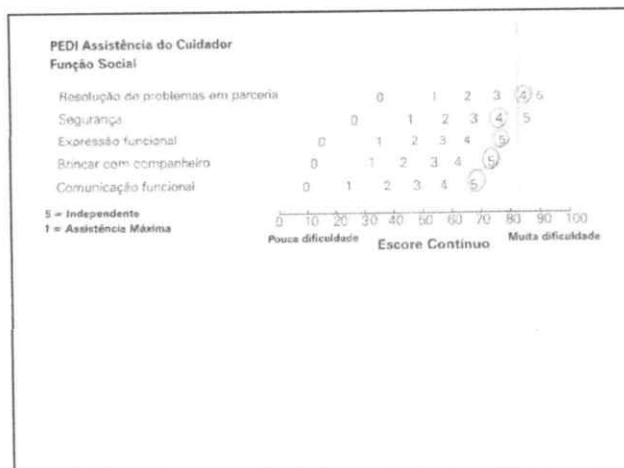
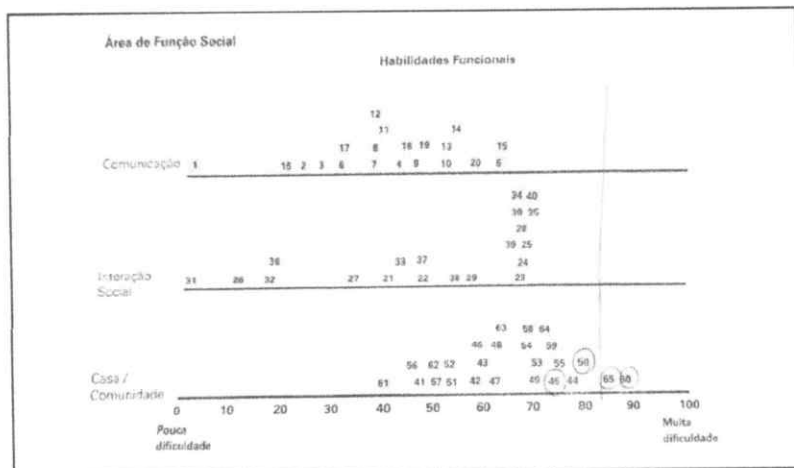
Orientações ao cuidador para estímulo à autonomia da criança :

A) Transferências no banheiro/cadeiras: Cadeiras de rodas infantil, cadeira de tamanho adulto, sanitário de tamanho adulto.

D) Transferências no chuveiro: Entrar e sair do chuveiro, abrir chuveiro, pegar sabonete e shampoo. Não inclui preparar para o banho

G) Escadas: Subir e descer um lance de escadas (12-15 degraus)

HABILIDADE FUNCIONAL – Função Social



Itens para intervenção :

45) Dirigir-se a um adulto para pedir auxílio sobre como voltar para a casa ou voltar ao quarto do hospital

50) Olhar o relógio regularmente ou perguntar as horas para cumprir o curso das obrigações

Orientações ao cuidador para estímulo à autonomia da criança :

E) Segurança: Cuidado quanto a segurança em situações da rotina diária, incluindo escadas, lâminas ou objetos quentes e deslocamentos

Conclusão e Conduta

Os itens descritos acima serão alvo de contextualização e orientação em reunião de pais para que haja estimulação constante vislumbrando o desenvolvimento da criança em todo o seu potencial.

Considerando o desenvolvimento funcional de Cecília dentro dos parâmetros para sua faixa etária e a qualidade de sua participação social, podemos com segurança propor alta do acompanhamento semanal em terapia ocupacional e programar reavaliação em 6 meses.

Atenciosamente,


Manon S. Faria G. Dias
 Terapeuta Ocupacional
 CREFITO 416104 TO
Manon Serva de Faria Guimarães Dias
 Terapeuta Ocupacional Crefito 6104 TO